

Lo que solo el hogar sabe · Documentos de trabajo · Documento DT-03
Borrador para comentarios. No citar sin contrastar.

La recuperación que no se distingue de cero

Necesidad de atención no satisfecha en Colombia, 2012–2025: por qué el diseño muestral cambia la conclusión y qué muestra el gradiente que el promedio esconde

Daniel A. Garavito Jiménez

Economista de la salud. Ex asesor de Innovación y Analítica, ADRES.
Procesamiento propio de los microdatos anonimizados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (DANE).
Septiembre de 2026

Versión 1.0 · 12 de septiembre de 2026 · Cítese la versión. Las correcciones posteriores a la publicación quedan con fecha en la fe de erratas: datos.sinergistica.com/erratas.html

Resumen

En 2025 la necesidad de atención no satisfecha fue de 35,9% (IC 95%: 33,1–38,7) frente a 38,1% en el nivel prepandémico. La diferencia de –2,2 puntos porcentuales se ha leído como recuperación del acceso. Con el error estándar correcto para el diseño bietápico, estratificado y por conglomerados de la encuesta, esa diferencia no se distingue de cero (EE 1,56; $z = -1,40$; $p = 0,1612$).

El punto es metodológico y tiene consecuencias. El efecto de diseño del indicador es 6,52: las 7.303 observaciones equivalen a 1.120 independientes, y el error estándar correcto es 2,55 veces el binomial. Con la fórmula binomial la misma diferencia arroja $z = -3,54$ y $p = 0,0004$, esto es, una mejora aparentemente decisiva. Ignorar el diseño no infla un intervalo: cambia la conclusión.

Mientras el nivel nacional no se mueve de forma concluyente, la desigualdad sí. El índice de concentración de Erreygers alcanzó en 2025 su valor más negativo de las trece rondas (–0,178); la brecha entre el quintil más pobre y el más rico es de 19,6 puntos ($p = 0,0044$) y la brecha entre zona rural y cabecera, de 16,5 puntos ($p < 0,0001$). Que la brecha nacional de ingreso supere a la calculada dentro de cada departamento indica que pesa más el territorio que la posición económica dentro de él.

Palabras clave

necesidad de atención no satisfecha; diseño muestral complejo; efecto de diseño; desigualdad en salud; índice de concentración; ENCV; SGSSS

1. El problema

La afirmación más repetida sobre el acceso a la salud en Colombia después de la pandemia es que se recuperó. Tiene una base aritmética real: en 2025 la necesidad de atención no satisfecha fue de 35,9% y el nivel prepandémico —el promedio de 2018 y 2019— era de 38,1%. La diferencia, –2,2 puntos porcentuales, apunta a la mejora.

Este documento sostiene que esa afirmación no se sostiene, y que la razón por la que se sostuvo tanto tiempo es metodológica. Con el error estándar correcto para el diseño muestral de la encuesta, la diferencia **no se distingue de cero**: $z = -1,40$, $p = 0,1612$. Con el error estándar binomial —el que se obtiene al tratar la muestra como si fuera aleatoria simple— la misma diferencia arroja $z = -3,54$ y

$p = 0,0004$, es decir, una mejora aparentemente decisiva. El diseño de la encuesta no es un detalle de anexo técnico: en este caso cambia la conclusión.

Y hay algo más incómodo. La trayectoria de los últimos cuatro años no es la de una recuperación que se estabiliza sino la de un ascenso sostenido desde el piso de la pandemia: 24,7% en 2021, 24,8% en 2022, 25,2% en 2023, 30,9% en 2024 y 35,9% en 2025. El indicador no volvió a su nivel prepandémico: *está volviendo*, y en la dirección equivocada.

Los dos hallazgos. *Primero: no hay evidencia de que el acceso general esté hoy mejor ni peor que antes de la pandemia; la afirmación correcta es que no se puede distinguir. Segundo: mientras el nivel nacional no se mueve de forma concluyente, la desigualdad sí. El índice de concentración de Erreygers alcanzó en 2025 su valor más negativo de las trece rondas (-0,178) —un ordenamiento descriptivo, no un contraste— y la brecha entre el quintil más pobre y el más rico es de 19,6 puntos, esta sí con prueba formal ($p = 0,0044$). El promedio quieto esconde una distribución que se abre.*

2. Marco: el indicador y su trampa

La necesidad de atención no satisfecha es el indicador de acceso más usado en comparaciones internacionales y el más fácil de calcular mal. Su forma correcta es **condicional**: se pregunta primero si la persona tuvo un problema de salud y solo a quienes lo tuvieron se les pregunta si recibieron atención. EU-SILC adoptó esa lógica de dos etapas en su revisión de 2015 justamente porque calcular el indicador sobre la población total mezcla dos cosas distintas —cuánta gente se enferma y cuánta gente no logra atenderse— y produce un número que sube cuando mejora la salud.

La trampa que le sigue es más sutil y menos discutida. El indicador es *autorreportado en las dos etapas*. La necesidad la declara la persona. Y hay una regularidad documentada en la literatura de desigualdades en salud: las poblaciones con peor acceso histórico **normalizan la privación** y reportan menos necesidad insatisfecha de la que un observador externo registraría, porque han ajustado sus expectativas a lo que el sistema les ha dado. Sen la llamó la adaptación de las preferencias; en medición de acceso se conoce como la paradoja del reporte. Su efecto va siempre en la misma dirección: **aplana el gradiente**. Cualquier brecha socioeconómica estimada con este indicador es, por ese motivo, un piso.

De ahí una consecuencia que organiza el resto del documento: el número más informativo de esta serie no es su nivel sino su *dispersión*. El nivel arrastra sesgo de expectativas; la comparación entre grupos arrastra el mismo sesgo, pero en la dirección que hace las brechas más pequeñas, no más grandes. Cuando una brecha estimada así es grande y significativa, la brecha verdadera lo es más.

3. Datos y método

3.1 Construcción

El indicador se construye sobre P5665 —problema de salud, enfermedad o accidente en los últimos treinta días— y P6153 —si no recibió atención médica y por qué—. El denominador son las personas que reportaron el problema de salud: 7.303 observaciones sin ponderar en 2025. La ventana de recordación es de treinta días, no de doce meses como en EU-SILC, de modo que **las cifras no son comparables con las europeas** en nivel; sí lo son en estructura y en gradiente.

3.2 Por qué el error estándar cambia la conclusión

La ENCV tiene diseño bietápico, estratificado y por conglomerados. Dos personas del mismo hogar y dos hogares del mismo segmento se parecen entre sí más de lo que se parecerían dos personas escogidas al azar del país. Esa correlación intraconglomerado reduce la información efectiva de la muestra, y la fórmula binomial —que supone independencia— la ignora por completo.

El efecto de diseño de este indicador en 2025 es **6,52**. En términos directos: las 7.303 observaciones producen la misma precisión que **1.120** observaciones independientes. El error estándar correcto es

2,55 veces el binomial. El cuadro 2 muestra qué le hace eso a la conclusión.

Estimador de la varianza	EE($\hat{p}_{2025}$) (pp)	EE(dif) (pp)	z	p	Conclusión
Binomial (ignora el diseño)	0,56	0,62	-3,54	0,0004	mejoró
Linealización de Taylor	1,43	1,56	-1,40	0,1612	no se distingue de cero

Cuadro 2. La misma diferencia —2,2 puntos porcentuales de 2025 frente al promedio de 2018–2019— evaluada con dos estimadores de varianza. La fila resaltada es la correcta bajo el diseño de la encuesta. No es una discusión de matices: es la diferencia entre afirmar una mejora y no poder afirmar nada. Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV-DANE.

El error estándar se obtiene por linealización de Taylor con el estimador de último conglomerado, usando las variables de diseño disponibles en el microdato de 2022, 2024 y 2025 y una corrección declarada por indicador en los años restantes. Los intervalos son logit (Korn y Graubard, 1998). El contraste compara cada dominio contra el resto del país, no contra el total.

4. Resultados

4.1 La serie: un piso pandémico y un ascenso

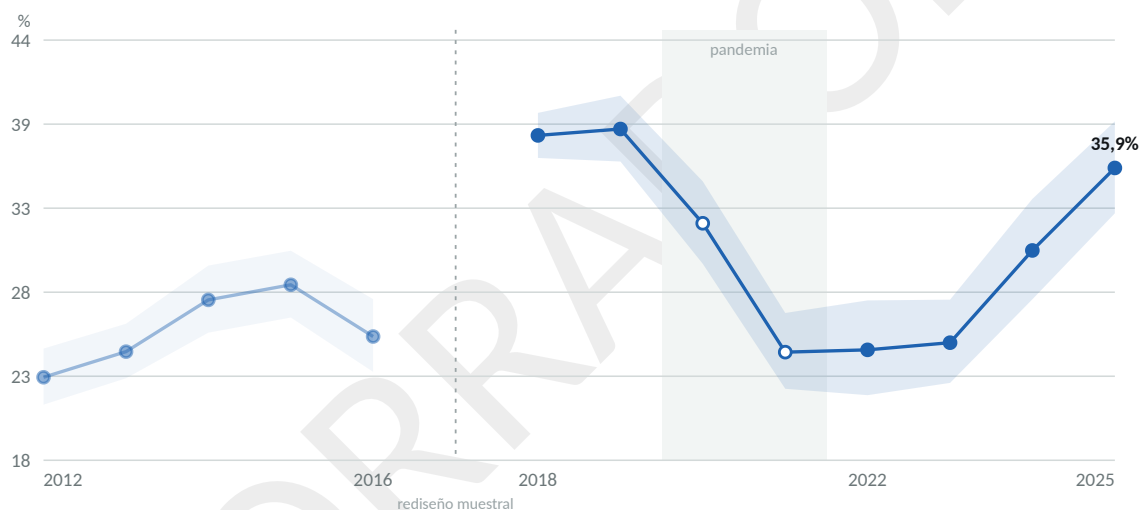


Figura 1. Necesidad de atención no satisfecha entre quienes reportaron un problema de salud, 2012–2025. Banda: IC 95% logit. Tramo atenuado: diseño anterior a 2018, no comparable. La recta punteada y tenue es la regresión del tramo vigente sin años de pandemia: su pendiente (–1,02 pp/año) no se distingue de cero ($p = 0,3546$, $R^2 = 0,215$). Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV-DANE.

Ronda	$\hat{p}$ (%)	EE (pp)	IC 95%	CV	n	deff	n_{ef}	E
2012	23,11	0,87	21,4–24,9	0,038	7.889	3,39	2.326	–0,120
2013	24,69	0,85	23,1–26,4	0,035	8.041	3,13	2.567	–0,130
2014	27,84	1,05	25,8–29,9	0,038	6.490	3,55	1.829	–0,124
2015	28,76	1,04	26,8–30,8	0,036	6.778	3,57	1.898	–0,060
2016	25,60	1,13	23,4–27,9	0,044	5.035	3,39	1.484	–0,091
2018	37,88	0,70	36,5–39,3	0,019	19.702	4,14	4.761	–0,141
2019	38,28	1,03	36,3–40,3	0,027	15.755	7,02	2.244	–0,067
2020	32,52	1,29	30,0–35,1	0,040	7.030	5,31	1.325	–0,138
2021	24,65	1,18	22,4–27,0	0,048	7.129	5,37	1.327	–0,054
2022	24,80	1,48	22,0–27,8	0,060	6.553	7,67	855	0,002
2023	25,23	1,30	22,8–27,9	0,051	6.382	5,69	1.122	–0,125
2024	30,85	1,57	27,9–34,0	0,051	7.049	8,09	871	–0,120
2025	35,89	1,43	33,1–38,7	0,040	7.303	6,52	1.120	–0,178

Cuadro 1. Serie completa. E es el índice de concentración de Erreygers sobre el quintil de ingreso per cápita: más negativo, más concentrado el problema en los hogares pobres. El valor de 2025 es el más negativo de las trece rondas, pero conviene no forzar esa frase: el índice se reporta sin error estándar, de modo que «el más negativo» es un ordenamiento y no una diferencia probada. El único año cualitativamente distinto del resto es 2022, el único con signo positivo. La prueba de desigualdad que este documento defiende es el contraste entre quintiles del cuadro 3, no la posición de 2025 en este ranking. Se reporta como estimación puntual, sin error estándar. Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV–DANE.

Conviene detenerse en el punto de 2021. Que el indicador cayera a 24,7% en plena pandemia no significa que el acceso mejorara: significa que menos gente buscó atención y que quienes lo hicieron enfrentaron un sistema con menos demanda. Un indicador condicional a la búsqueda se abarata cuando la búsqueda se contrae. Tomar ese punto como referencia —como hace cualquier comparación «frente a 2021» o «frente a 2023»— convierte el retorno a la normalidad en un desplome inventado. Es la razón por la que este trabajo ancla todo en 2018–2019.

4.2 El promedio quieto y la distribución que se abre

Contraste	Grupo A (%)	Grupo B (%)	Dif. (pp)	EE (pp)	z	p
Quintil nacional más pobre frente al más rico	41,0	21,4	+19,6	6,88	2,85	0,0044
Quintil del propio departamento, más pobre frente al más rico	40,3	26,4	+13,8	6,70	2,07	0,0388
Centro poblado y rural disperso frente a cabecera	49,1	32,6	+16,5	2,90	5,69	< 0,0001
Se reconoce en un grupo étnico frente a quien no	45,7	34,7	+11,0	3,52	3,12	0,0018

Cuadro 3. Contrastes de equidad en 2025. Los tres primeros son las brechas clásicas; el segundo es la misma brecha de ingreso calculada dentro de cada departamento. Los contrastes por clase son exactos bajo el diseño; los de quintil y etnia son aproximados, porque los grupos comparten conglomerados. Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV–DANE.

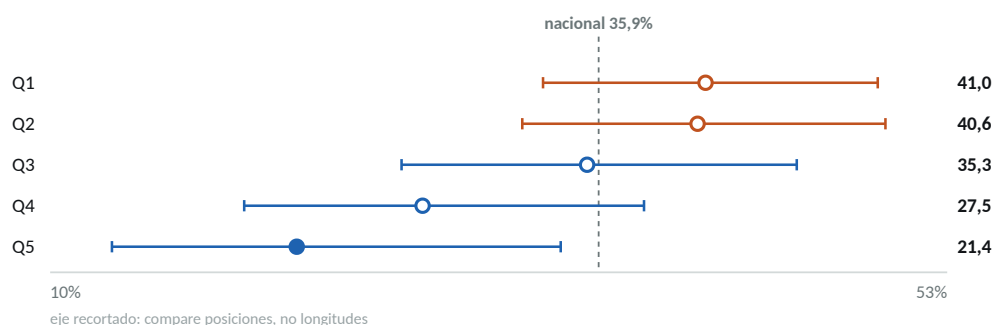


Figura 2. Necesidad de atención no satisfecha por quintil nacional de ingreso per cápita, 2025. Punto lleno: el contraste contra el resto del país alcanza $p < 0,05$. El gradiente es monótono en los cinco quintiles. Eje recortado. Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV-DANE.

Las dos brechas de ingreso del cuadro 3 responden preguntas distintas y su comparación es el resultado más útil para el diseño de política. La brecha *nacional* —19,6 puntos— compara al quintil más pobre del país con el más rico del país. La brecha *geográfica* —13,8 puntos— corta la distribución de ingreso dentro de cada departamento y compara a los pobres de cada territorio con los ricos de ese mismo territorio. La primera es mayor que la segunda, y la lectura tentadora es que **pesa más en qué departamento vive la persona que su posición económica dentro de ese departamento**. Conviene, sin embargo, someter esa lectura a la misma prueba que este documento le exige a todo lo demás. La diferencia entre las dos brechas es de 5,76 puntos con un error estándar de 9,60 — $z = 0,60$, $p = 0,5486$ —: **no se distingue de cero**. Las dos brechas son ambas grandes y ambas significativas por separado; cuál de las dos pesa más es una pregunta que estos datos no resuelven. La afirmación defendible es la débil: el componente territorial de la desigualdad de acceso es al menos tan grande como el componente de ingreso dentro del territorio, y por tanto una política de focalización individual que ignore la geografía deja fuera, como mínimo, la mitad del problema.

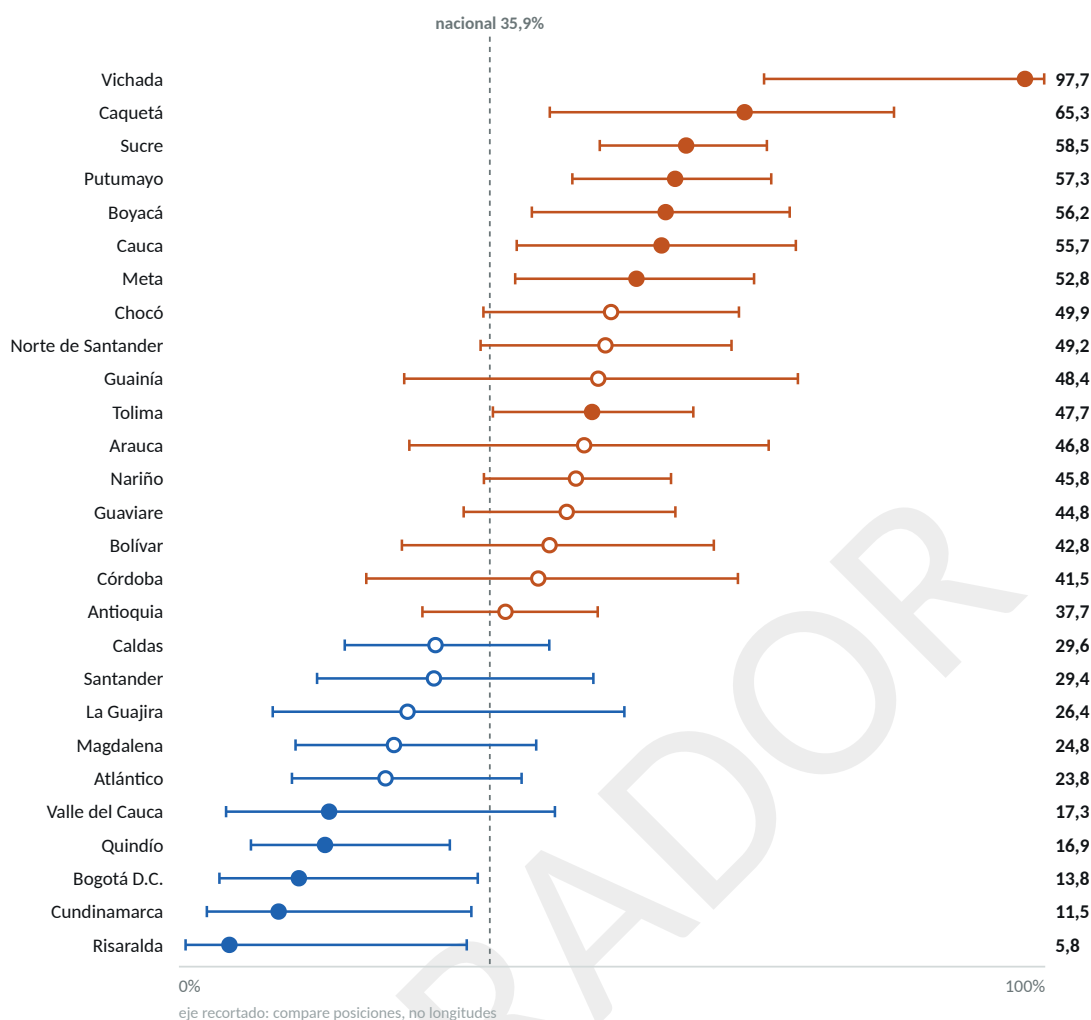


Figura 3. Necesidad de atención no satisfecha por departamento, 2025. Aparecen los 27 departamentos que superan el mínimo de cien observaciones en el denominador. Punto lleno: el contraste contra el resto del país alcanza $p < 0,05$. Los intervalos son muy desiguales: compare posiciones, no longitudes de barra. Eje recortado. Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV-DANE.

El rango es extremo: de 5,8% en Risaralda a 97,7% en Vichada. Y el valor de Vichada exige una advertencia que va más allá de la imprecisión ordinaria. Su intervalo va de 67,5 a 99,9% sobre 122 observaciones sin ponderar; su tamaño efectivo de muestra es de apenas 18,7, de modo que el recuento efectivo en la celda complementaria —los que sí recibieron atención— es de **0,44**, por debajo de uno. En esa región la aproximación normal simplemente no rige, y por eso el intervalo logit y el contraste contra el resto del país se contradicen: el primero admite valores desde el 67,5%, mientras el segundo devuelve un z de 16,4 que sugeriría certeza. Ninguna de las dos cifras debe citarse como estimación. Lo que este dato es, y es valioso, es una **alerta**: señala un departamento que debe mirarse con otra fuente, no una magnitud que pueda llevarse a un debate.

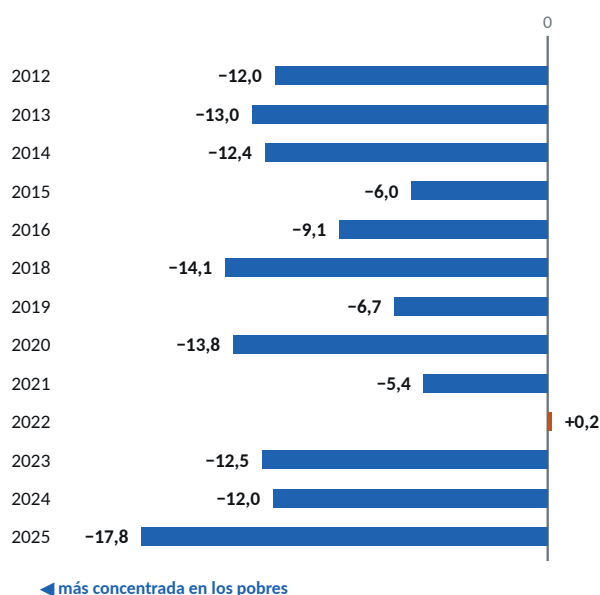


Figura 4. Índice de concentración de Erreygers de la necesidad no satisfecha, año por año. Todos los valores son negativos salvo 2022: el problema se concentra sistemáticamente en los hogares de menor ingreso. 2025 ocupa el extremo de esa ordenación. El índice se reporta sin error estándar, de modo que la figura ordena y no prueba: solo 2022 se aparta cualitativamente del resto. El contraste formal de desigualdad es el del cuadro 3. Fuente: cálculos del autor sobre microdatos ENCV-DANE.

5. Interpretación

La lectura que este documento propone tiene tres partes. La primera es de disciplina: **«no se distingue de cero» no es «no cambió»**. Es una afirmación sobre lo que estos datos permiten concluir, no sobre el mundo. Con seis rondas anuales, un efecto de diseño de 6,52 y un denominador condicional que se estima sobre una fracción de la muestra, la encuesta tiene poca potencia para detectar cambios moderados en el nivel nacional. Una mejora real de dos puntos es perfectamente compatible con lo observado; también lo es un deterioro de uno. Decir «el acceso volvió» es afirmar más de lo que el dato sostiene.

La segunda es sustantiva: **el nivel es el indicador menos informativo de esta serie**. Está contaminado por la adaptación de expectativas, por la variación en la propensión a reportar enfermedad y por la composición de quienes buscan atención. La estructura —el gradiente, el rango territorial, el índice de concentración— es mucho más robusta a esos sesgos, porque los sesgos operan en la misma dirección en todos los grupos y en buena parte se cancelan al comparar.

La tercera es la que importa para la política: en el año en que el nivel no se movió de forma concluyente, la concentración en los hogares pobres alcanzó su máximo de trece rondas. La combinación de un promedio estable con una desigualdad creciente es la firma de un sistema que redistribuye el problema hacia abajo mientras mantiene el agregado. Ningún tablero que reporte solo el nivel nacional —y son casi todos— puede ver eso.

6. Referencia internacional: comparable en estructura, no en nivel

Este indicador sí tiene un referente internacional consolidado, y es el único de los cuatro que examina el documento DT-07 de esta serie para el que existe una serie armonizada: la de EU-SILC, la encuesta de ingresos y condiciones de vida de la Unión Europea.

Eurostat publica dos versiones. La primera, sobre el total de la población de dieciséis años y más, sitúa el promedio de la UE-27 en 2,4 % en 2025. La segunda —`hlth_silc_08b`, cuyo denominador son las personas que declararon esa misma necesidad, y por tanto el análogo del

denominador colombiano— sitúa a la **UE-27 en 3,6 %** tanto en 2024 como en 2025, con Grecia en el extremo alto (21,9 % en 2024; 20,0 % en 2025) y Chipre en 0,1 %.

Colombia registra 35,9 %. **Poner las dos cifras en una misma tabla sería un error**, por cuatro razones simultáneas:

- **La ventana de recordación.** Doce meses en Europa, treinta días en Colombia.
- **Las razones admitidas.** La serie europea restringe el indicador a tres motivos —demasiado caro, lista de espera, demasiado lejos—; la colombiana admite cualquiera.
- **La edad.** La europea se limita a mayores de dieciséis años; la colombiana cubre toda la población.
- **La formulación del ítem**, que no es idéntica.

Ahora bien, esas diferencias no hay que enunciarlas: hay que hacerles la aritmética. Y hacerla cambia la conclusión. Es verdad que una ventana de treinta días produce mecánicamente prevalencias más bajas que una de doce meses —cuanto más corto el periodo de referencia, menos episodios caben en él— y ese sesgo juega en contra de Colombia. Pero no es el sesgo dominante. El dominante es la restricción de razones, y juega en el sentido opuesto y con mucha más fuerza.

La reponderación es directa. Si del indicador colombiano se conservan únicamente las razones que EU-SILC admite —falta de dinero, y distancia o dificultad para viajar—, el 35,9 % baja a **3,51 %** (IC 95 %: 2,63–4,39), frente al 3,6 % de la UE-27. Son cifras indistinguibles. Si además se añaden, como cota superior generosa, todas las razones de oferta —mal servicio, cita distanciada, lo hacen esperar mucho, no lo atendieron— para sustituir la «lista de espera» europea, el resultado sube a **7,76 %** (6,27–9,25): alrededor del doble del promedio europeo, y aún así un orden de magnitud por debajo de la cifra bruta.

De ahí se siguen tres cosas, y la tercera es la incómoda. Primera: «35,9 frente a 3,6» no era una comparación, era un artefacto del instrumento; casi toda la brecha aparente la produce la lista de razones, no el sistema de salud. Segunda: la lectura contraria —que la ventana corta hunde la cifra colombiana y por tanto la brecha real sería aún mayor— es incorrecta, porque atiende al sesgo pequeño y omite el grande. Tercera: la reponderación tampoco es un ranking. La ventana sigue sin corregir, la formulación del ítem difiere y el sustituto de «lista de espera» es imperfecto por exceso. Lo que estas cifras entregan es un intervalo defendible, no un puesto en una tabla.

Conviene subrayar lo que ese ejercicio deja en pie, porque es un hallazgo mejor que el que reemplaza. Para las razones que Europa mide, Colombia está en el rango europeo. Lo que Colombia tiene y Europa dejó de medir en 2015 es la barrera administrativa —el trámite y la autorización—, y es exactamente ahí donde esta serie encuentra el deterioro. El indicador que nos distingue no es el que nos deja mal parados en la comparación: es el que la comparación no puede ver.

Hay un segundo referente, de otra naturaleza. El ODS 3.8.1 —índice de cobertura de servicios de salud esenciales, un compuesto de catorce indicadores trazadores en escala de 0 a 100— sitúa a Colombia en **82** en 2023, frente a 79 de América Latina y el Caribe y 71 del promedio mundial. Ese índice mide cobertura *efectiva de servicios*, no afiliación, y la distancia entre él y el 97,2 % de afiliación es exactamente lo que este indicador está midiendo.

Sobre el umbral de cumplimiento: no existe. La Observación General 14 del Comité DESC de la ONU es deliberadamente no numérica —invita a cada Estado a fijar sus propias referencias— y el informe anual de goce efectivo del derecho que el artículo 7 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 ordena publicar no declara meta alguna para acceso. El documento DT-07 de esta serie desarrolla ese vacío y sus consecuencias.

7. Límites

Adaptación de expectativas. Es el límite dominante y va en una sola dirección: subestima el problema donde el acceso es peor. Las brechas de este documento son pisos. Nunca debe leerse este indicador aislado: va acompañado de utilización efectiva y de gasto de bolsillo, que no comparten ese sesgo.

Ventana de treinta días. No comparable en nivel con EU-SILC ni con las cifras europeas de necesidad no satisfecha, que usan doce meses.

Dominios pequeños. Las estimaciones departamentales tienen intervalos muy anchos, y el contraste de dominio usa el efecto de diseño nacional aplicado a la varianza binomial del dominio. Ese procedimiento supone que el dominio está tan conglomerado como el país; en departamentos pequeños el efecto de diseño real suele ser mayor, de modo que los errores estándar aquí son, si acaso, conservadoramente pequeños. La cifra de Vichada debe citarse con su intervalo, siempre.

Cortes transversales, no panel. La serie muestra cuándo cambia un nivel, nunca por qué. Ninguna coincidencia temporal entre una política y un quiebre de la serie constituye evidencia de efecto.

El contraste de quintil es aproximado. Se omite el término de covarianza entre el dominio y su complemento, que en cortes no geográficos no es nulo.

8. Implicaciones de política

Primero: retirar la afirmación de recuperación. No hay base estadística para sostener que el acceso general esté hoy mejor que antes de la pandemia. Quien la use —en cualquier dirección del debate— está citando una diferencia que no se distingue del ruido muestral. La formulación defendible es que el nivel nacional no ha cambiado de forma detectable desde 2018–2019, mientras la desigualdad sí.

Segundo: reportar el gradiente, no el promedio. El indicador de política útil no es el nivel nacional sino la brecha entre quintiles y el rango territorial, ambos con su incertidumbre. Es una recomendación concreta para los informes de goce efectivo del derecho que el artículo 7 de la Ley Estatutaria ordena al Ministerio.

Tercero: la política es territorial antes que individual. Que la brecha nacional supere a la brecha dentro del departamento dice dónde está la palanca. Focalizar hogares en departamentos sin oferta no resuelve el problema que este dato describe.

Cuarto: publicar el módulo de diseño de toda la serie. La demostración del cuadro 2 solo es posible en los años en que el DANE publica estrato y segmento. Sin ese módulo, cualquier tercero que quiera evaluar una afirmación de acceso queda obligado a la fórmula binomial, que es exactamente la que produce la conclusión equivocada.

·. Referencias

- Allin, S., Grignon, M., y Le Grand, J. (2010). Subjective unmet need and utilization of health care services in Canada: what are the equity implications? *Social Science & Medicine*, 70(3), 465–472.
- Congreso de Colombia. (2015). *Ley Estatutaria 1751 de 2015*, artículos 6 y 7. Diario Oficial 49.427.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2026). *Boletín técnico: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025*. Bogotá: DANE.
- Erreygers, G. (2009). Correcting the concentration index. *Journal of Health Economics*, 28(2), 504–515.
- Eurostat. (2018). *Methodological guidelines and description of EU-SILC target variables: unmet need for medical examination*. Luxemburgo.
- Kish, L. (1965). *Survey sampling*. Nueva York: Wiley.
- Korn, E. L., y Graubard, B. I. (1998). Confidence intervals for proportions with small expected number of positive counts estimated from survey data. *Survey Methodology*, 24(2), 193–201.
- Lumley, T. (2010). *Complex surveys: A guide to analysis using R*. Hoboken: Wiley.
- Sen, A. (2002). Health: perception versus observation. *BMJ*, 324(7342), 860–861.
- Wagstaff, A., van Doorslaer, E., y Watanabe, N. (2003). On decomposing the causes of health sector inequalities with an application to malnutrition inequalities in Vietnam. *Journal of Econometrics*, 112(1), 207–223.
- Eurostat. (2026). *Self-reported unmet needs for medical examination due to financial reasons, long waiting list or distance — % of the persons having the same needs* (serie hlth_silc_08b). Luxemburgo.
- Organización Mundial de la Salud. (2025). *Global Health Observatory: UHC service coverage index (SDG 3.8.1)*. Ginebra.

Descargo. Las opiniones, análisis y propuestas de este documento son exclusivamente del autor, a título personal. No comprometen a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), al Ministerio de Salud y Protección Social, ni a ninguna otra entidad del sector. El trabajo se elabora íntegramente a partir de fuentes de acceso público: microdatos anonimizados del DANE, normatividad publicada, informes oficiales y bases de datos internacionales abiertas. No emplea información reservada, datos personales de beneficiarios ni información de operación contractual. Las propuestas son hipótesis de discusión, no compromisos institucionales.

Serie «Lo que solo el hogar sabe · Documentos de trabajo». El código de procesamiento, el catálogo de campos y las verificaciones contra los boletines oficiales son reproducibles. Cualquier error es responsabilidad del autor.